

8.2.15. Siltuximab (如 Sylvant):(113/2/1)

1. 限免疫過敏或血液腫瘤專科醫師處方。
2. 限用於治療人類免疫不全病毒(HIV)陰性及人類皰疹病毒-8 (HHV-8)陰性的多發性 Castleman 氏病(Multicentric Castleman's Disease(MCD))患者，ECOG $\leq$ 2。
3. 需經事前審查核准後使用。初次申請時，以6個月為限，之後每3個月再次申請，再次申請時應檢附前次治療結果評估資料，如血液學或影像學檢查報告。
4. 病人需符合與 iMCD 譜系(iMCD spectrum)一致的組織病理學淋巴結特徵。
5. 病人需至少在2個淋巴結分區(lymph node stations)有淋巴結腫大(短軸直徑至少1 cm)。
6. 申請時須註明，病人至少符合2項以上 iMCD 診斷標準(iMCD 實驗室診斷標準(laboratory iMCD diagnostic criteria)或 iMCD 臨床診斷標準(clinical iMCD diagnostic criteria))，且至少1項須為實驗室診斷標準。
7. 排除其他疾病因素：
 - (1)人類皰疹病毒-8感染。
 - (2)Epstein-Barr 病毒淋巴增生性疾病。
 - (3)急性/不受控制的感染(如巨細胞病毒、弓形蟲病、人類免疫缺陷病毒、肺結核)所導致的炎症並伴有淋巴結腫大。
 - (4)自身免疫/自體發炎性疾病。
 - (5)惡性/淋巴增生性疾病。
8. 停用時機：
 - (1)初次治療前6個月未符合治療改善之定義，停止使用。
 - (2)維持治療：每3個月評估直到疾病進展(Progression Disease)則停止治療。
 - (3)若疾病進展或無法耐受藥物副作用，則必須停止使用。
9. 最長使用2年，復發時依初次使用標準審查。

備註：

1. iMCD 實驗室診斷標準(laboratory iMCD diagnostic criteria)：

(1)CRP 升高(>10mg/L)或紅血球沉降速率(erythrocyte sedimentation rate, ESR)升高 (>15mm/h)。

(2)貧血 (男性血紅蛋白<12.5g/dL；女性血紅蛋白<11.5g/dL)。

(3)血小板減少症(血小板數<150k/mL)或血小板增多症(血小板數>400k/mL)。

(4)低白蛋白血症(白蛋白<3.5g/dL)。

(5)腎功能異常 (eGFR<60mL/min/1.73m²) 或蛋白尿 (總蛋白質150mg/24h 或 10mg/100mL)。

(6)多株高丙型球蛋白血症 (polyclonal hypergammaglobulinemia) (總 g 球蛋白或免疫球蛋白 G>1700mg/dL)。

2. iMCD 臨床診斷標準(clinical iMCD diagnostic criteria)：

(1)全身症狀：盜汗、發燒(>38⁰C)、體重減輕或疲勞 (使用不良事件通用術語標準，該症狀至少2分 (CTCAE grade II 以上))。

(2)肝和/或脾臟增大。

(3)積水：水腫、全身水腫、腹水或胸腔積水。

(4)爆發性櫻桃狀血管瘤或紫羅蘭色丘疹。

(5)淋巴細胞間質性肺炎。

3. 治療改善狀況根據 (CDCN response criteria)；需同時滿足下列 (1) ～

(2) 條件；每3個月評估：

(1)至少與基礎比較改善，發炎反應的客觀指標，以下4個數值有2個符合：

I. C-反應蛋白(CRP)下降50%。

II. 血紅蛋白(Hemoglobin)上升2g/dL 或 ≥10g/dL。

III. 白蛋白(Albumin) ≥3.5/dL。

IV. 腎絲球過濾率 GFR 上升20%或 GFR ≥60mL/min/1.73m²。

(2)淋巴結較基礎值可測量縮小50%或無新發生淋巴結節腫大(每半年執行檢測一次)。